جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : اماني عبدالرحمن احمد بدر
المحافظة : كفر الشيخ **الحي / المدينة :** بيلا **العنوان :** ش الامام ابي حنيفه
رقم البطاقة : 26902061501942 **رقم التليفون :** 01154054530 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 06-02-1969 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: امانى عبدالرحمن احمد بدر
National ID: 26902061501942

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





803

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: [illegible] امنى عبدالرحمن احمد بدر	Request No.	: 13001715
Patient No.	: 26902061501942	Request Date	: 02/08/2022
Path No.	: 2169/22	Verification Date	: 17/08/2022
Sex	: Female	Financial Category	: [illegible]
Age	: 53 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

CLINICAL DATA: Left breast cancer, post NACT
NATURE OF SPECIMEM: Left MRM
GROSS EXAMINATION:
• Procedure: Left MRM
measured 30x16x8 cm with covering skin ellipse measured 23x13 cm .
• Tumor extent : A greyish white tumour bed site
• Size: 3.5 x3 x2 cm .
• Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
• Distance from margins: 2 cm away from deep margin , 2 cm away from the skin .
• Lymph nodes number and size: 12 L Ns up to 1.5x1.5 cm .
MICROSCOPIC EXAMINATION:
• Histological type: No residual viable tumor
• Ductal carcinoma in situ: Focal (3%)
• Skin involvement: Free nipple and areola
• Lymph node involvement: Positive L Ns (1/12) with extracapsular invasion
• Resection Margins: Free margins
• Histologic response to therapy: Pathologic partial response
DIAGNOSIS:
Left MRM (post NACT) :
No residual viable tumor in a previously diagnosed invasive duct carcinoma grade II
• Free margins
• Free nipple and areola
• Positive L.Ns (1/12) with extracapsular invasion
• Pathologic partial response
• Stage : ypTis , ypN1
• RCB : 1.205 , RCB class I

Prof. Dr. Gamal Abdelatty

Dr.Samah Sayed

Verified by :
saamah sayed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: امانى عبدالرحمن احمد بدر **MR. :** 10072	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 53-year-old postmenopausal individual with a left breast T4 N1 M0 invasive ductal carcinoma, estrogen receptor 7/8, progesterone receptor 4/8, HER2 3+. The patient received neoadjuvant chemotherapy with TCHP for six cycles. The patient underwent modified radical mastectomy with axillary clearance, placement of a radiation port, and adjuvant anti-HER2 therapy. The patient also received adjuvant aromatase inhibitor therapy (arimidex) and zoledronic acid (Zometa) today. Laboratory work-up was performed outside the cancer center and no creatinine value was reported. The patient has completed 6 cycles of TCHP.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر

يعتمد ,

Patient Name	:	Request No.	: 13008626
Patient No.	: 26902061501942	Request Date	: 05/03/2022
Path No.	: SR-156/2022	Verification Date	: 14/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 53 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Lt breast cancer
Nature of the specimen:
Slide revision
Gross Examination
Recieved only 5 slides

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Immunohistochemistry :

ER: Strong nuclear reaction in 90% tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Moderate nuclear reaction in 10% tumor cells(Allred score 4/8)
Her-2: Strong complete membrane reaction in >10% tumor cells (score 3+)
KI67: 30% nuclear reaction
Diagnosis:
Lt breast cancer, slide revision
-Invasive duct carcinoma , grade II
- IPT :
-ER : Positive (8/8)
-PR : Positive (4/8)
-HER2: Positivee(score 3+)
- KI67: 30%
Prof Dr.Gamal Abdelatty
Prof Dr.Amal Hareedy

Verified by :
dr.esraa magdy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GB Postoperative

MDT FORM

23.2.2022

Name		MRN	
Age	53 Y	ID	
Menopausal status		Phone	
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx: IDC grade II

ER: 7/8	PR: 4/8	HER2: +ve	KI67: 30%

Sonomammography:

R

Mets Workup:

Recommendations: Post NACT, post U MRM

- pathology: No residual viable in 9 diagnosed
- LNs: 9/12 With Extracapsular invasion

MDT OUTCOME & PLAN

1/9/2022 YP Tis, YP N1

- Path review & Pa — pathology test
- Re: Kadyla Re-tyé: C1D1/C2
- PORT
- Hx: stiff AI. + prolia 60mg

MEDICAL ONCOLOGY | SURGERY | SIGNATURE | RADIOLOGY | PATHOLOGY

Dr. Walid

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name : Mrs. Amani Abd El-Rahman Badr
Date : 27/02/2022 Code : R2663087

F-18 Fluorodeoxyglucose (FDG) PET/CT of the whole body:

CLINICAL HISTORY:

- Female patient , with recent pathologically proven left breast infiltrating duct carcinoma, referred for whole body survey.

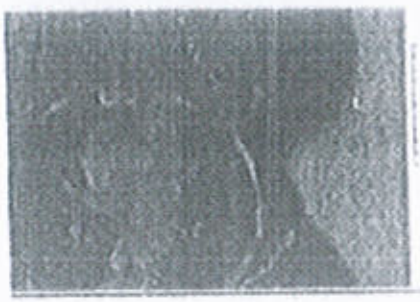
PROCEDURE:

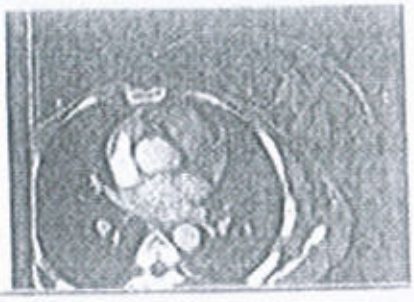
- Whole body 18F-FDG images from skull to mid thighs with the arms extending above the head were obtained.
- CT was acquired for the purpose of anatomic localization and attenuation correction.
- Data was processed and displayed according to departmental protocol.

FINDINGS:

LOCO-REGIONAL DISEASE:

- Left breast shows dense fibroglandular texture, with noted multifocal speculated mass lesions seen at LIQ, the most prominent one is seen retroareolar in location, measuring about 19x11mm with FDG avidity of SUVmax~11.9.
- Overlying skin thickening reaching about 1 cm at maximal thickness is also noted showing mild metabolic activity of SUVmax~2.2.

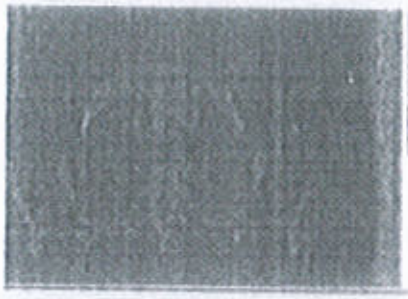


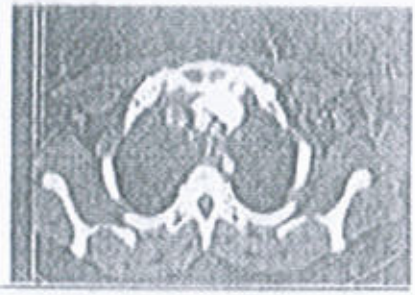


PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Name : Mrs. Amani Abd El-Rahman Badr
Date : 27/02/2022 Code : R2663087

- Multiple pathologically enlarged left axillary metabolically active lymph nodes, the largest measuring about 20x10mm showing intense FDG avidity of SUVmax~19.
- Right small non-specific axillary lymph nodes are noted.





I) BRAIN REVEALED:

- No evidence of intra-cerebral or extra-axial fresh blood density.
- Normal size and configuration of the ventricular system and subarachnoid basal cisterns as well as the cortical sulci on both sides.
- No definite cerebral areas of abnormal attenuation value.
- No shift of midline structures.
- Normal posterior fossa.
- Clear scanned para-nasal sinuses.

II) NECK REVEALED:

- Normal appearance of vallecula, pyriform fossae and aryepiglottic folds.
- Patent nasopharyngeal and Oro-pharyngeal air column.
- No evidence of enlarged or pathological lymph nodes.
- Normal appearance of the parotid and submandibular salivary glands.
- Normal appearance of the thyroid gland.
- Normal appearance of the carotid sheath and its contents.

III) THE CHEST REVEALED:

- Tiny calcified pulmonary nodule is seen at the apical segment right upper lobe likely post granulomatous sequal.

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Name : Mrs. Amani Abd El-Rahman Badr
Date : 27/02/2022 Code : R2663087

- No CT evidence of pulmonary masses or parenchymal abnormality detected.
- No pleural or pericardial collections.
- Normal tracer biodistribution is noted at the myocardium and great vessels.

IV) THE ABDOMEN AND THE PELVIS REVEALED:

- Mildly enlarged liver showing smooth regular outline with diffuse hypodense parenchymal texture. No evidence of definite enhanced focal hepatic masses or bile duct dilatation.
- Patent normal caliber and homogenously enhancing portal vein and its main branches.
- Normal appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, kidneys, aorta, IVC and pelvic organs
- No evidence of grossly enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No ascites.

V) THE MUSCULOSKELETAL

- FDG biodistribution is rather physiologic, with no significant blastic or lytic skeletal lesions could be seen on CT to account for metastatic disease to bone.

IMPRESSION:

Initial FDG PET CT study , for a pathologically proven left breast IDC, revealed:

- **Hypermetabolic left breast multifocal speculated soft tissue lesions associated with mild FDG avid skin thickening, as described keeping with site of primary neoplasm.**
- **Multiple FDG avid left axillary metastatic nodal deposits.**
- **No definite FDG avid distant metastases.**

Much Obliged

Prof. Hamed El-Ghawaby. ***Dr. Esraa El-Kholy, M.D.***
Assist. Professor of Nuclear medicine (NCI)
Cairo University

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on radreport@cairoscan.com.eg

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]